MANEJO DA
DOR CRÔNICA
NA APS

Neurociência básica da dor e a inter-relação entre os processos psicológicos, fisiológicos, ambientais e sociais na percepção da dor



Baixe e imprima este material em formato A4.

CUIDATIVA
CENTRO REGIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - UFPEL

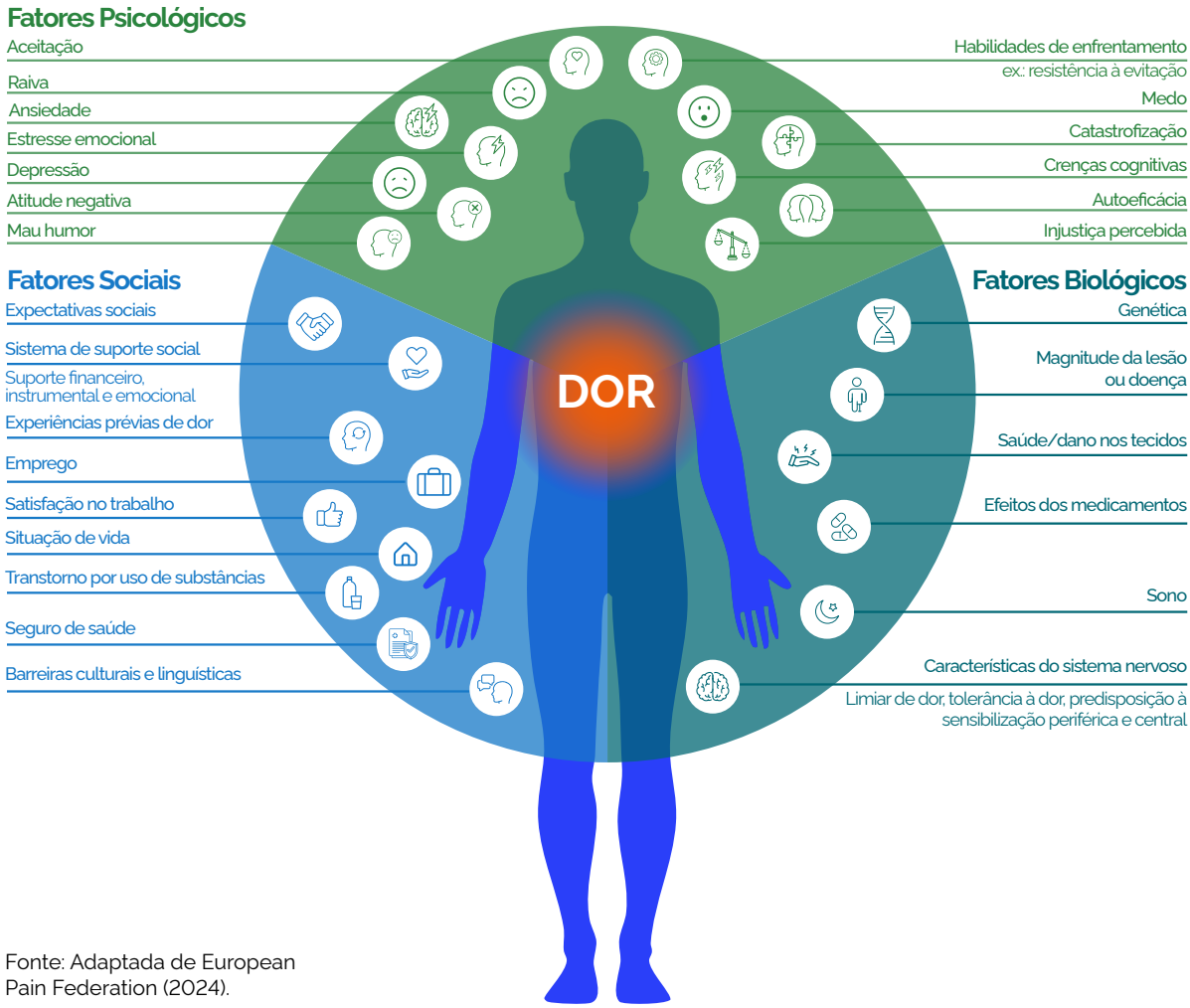
UFPEL

PNPIC
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS

SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

A dor é um fenômeno complexo que envolve não apenas aspectos fisiológicos, mas também psicológicos, sociais e espirituais.



Fonte: Adaptada de European Pain Federation (2024).

A neurociência básica da dor examina como essa experiência é processada pelo sistema nervoso e como esses diferentes fatores influenciam a percepção da dor.

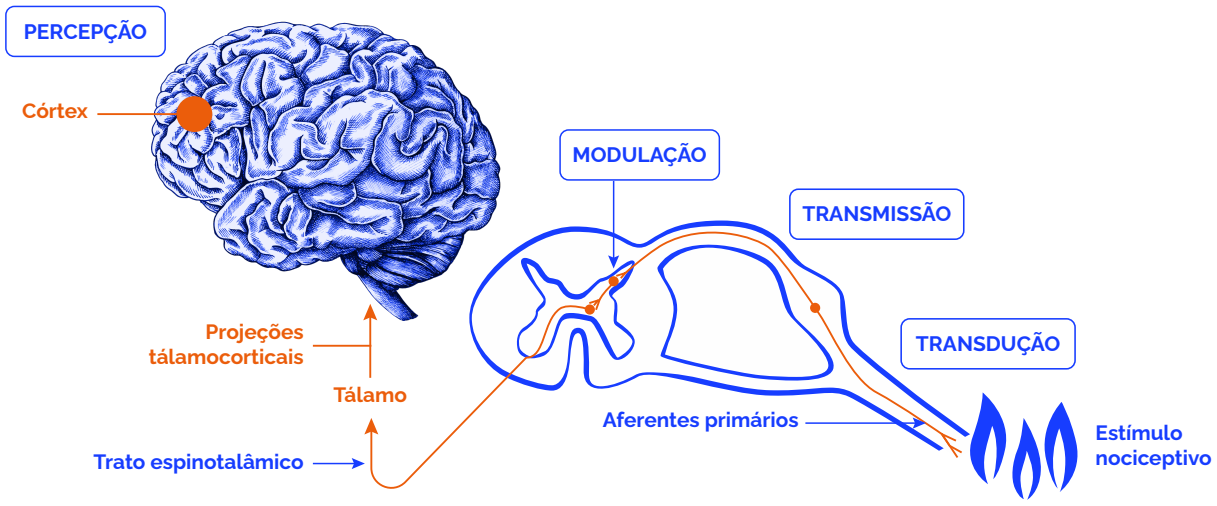
Neurociência básica da dor

A dor é uma sensação causada por estímulos nocivos (nociceptivos) que ativam receptores especializados, chamados nociceptores. Esses receptores estão localizados na pele, músculos, articulações e órgãos internos e respondem a estímulos como calor excessivo, pressão, lesão ou inflamação. Quando ativados, os nociceptores transmitem sinais elétricos, ao longo das fibras nervosas, para a medula espinhal e, em seguida, para o cérebro, onde a dor é processada e interpretada (Baliki; Apkarian, 2015; Garland, 2012).

O processo pode ser dividido em algumas etapas principais:

- **Transdução:** a conversão dos estímulos nocivos em um sinal elétrico pelos nociceptores;
- **Transmissão:** o sinal elétrico é transmitido pelos nervos periféricos até a medula espinhal e, eventualmente, até o cérebro;
- **Modulação:** a dor pode ser modulada em diferentes níveis do sistema nervoso central (SNC) e ser amplificada ou atenuada por fatores fisiológicos, psicológicos e sociais, o que permite ao indivíduo sentir dor, de menor ou maior intensidade, ou não sentir dor;
- **Percepção:** o cérebro processa o sinal, o que resulta na sensação consciente da dor, já o córtex cerebral é responsável por identificar a localização, a intensidade e o tipo da dor.

Figura 1 — Neurociência básica da dor



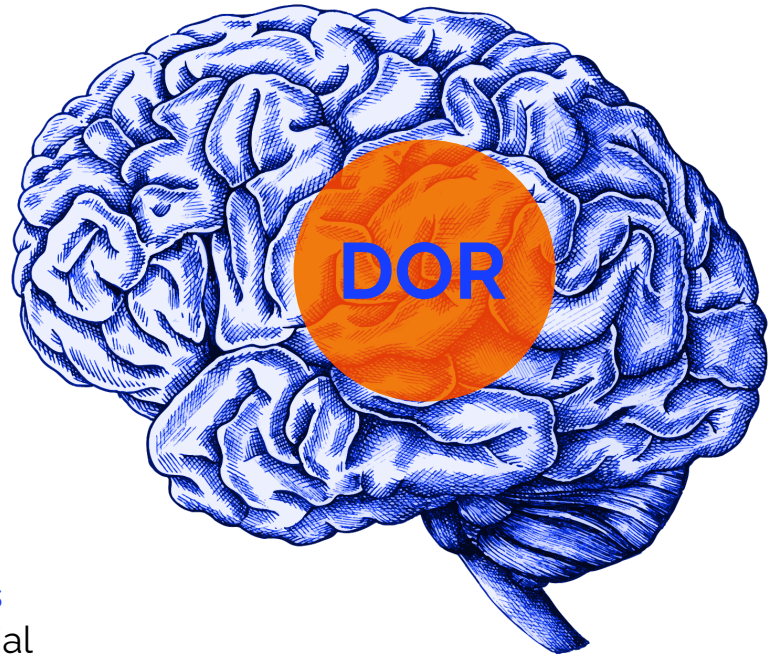
Fonte: Adaptada de Ashmawi (2016).

Figura 2 — Inter-relação entre processos psicológicos, fisiológicos, ambientais e sociais na percepção da dor

Fatores fisiológicos
- Neuromodulação
- Sensibilização central
- Genética

Fatores psicológicos
- Expectativa
- Ansiedade e depressão
- Autoeficácia
- Catastrofização
- Medo e cinesiofobia

Fatores ambientais e sociais
- Cultura e Aprendizado Social
- Suporte social
- Ambiente



Fonte: Adaptada de Tracey (2008).

A percepção da dor não é apenas um reflexo direto da lesão física, mas é moldada por uma série de fatores externos e internos, inclusive na ausência de lesão. Esses fatores podem modificar a maneira como a dor é sentida e interpretada pelo indivíduo.

A.
Fatores Fisiológicos

1. Neuromodulação

O sistema nervoso central pode liberar substâncias como endorfinas, que são analgésicos naturais, ou neurotransmissores que inibem a dor, como GABA e serotonina. Além disso, o SNC pode inibir a liberação de neurotransmissores excitatórios, como glutamato, aspartato e substância P. É possível, ainda, que libere substâncias inflamatórias, como interleucinas, as quais têm a capacidade de aumentar (citocinas pró-inflamatórias, como interleucinas 1, 6, 8, 17 e fator de necrose tumoral alfa) ou reduzir (citocinas anti-inflamatórias, como interleucinas 1Ra, 4, 10, 13 e fator de crescimento transformador beta) a intensidade da dor (Baliki; Apkarian, 2015; Garland, 2012).

2. Sensibilização central

Em casos de dor crônica, o SNC pode se tornar mais sensível a estímulos, o que amplifica a percepção da dor, mesmo na ausência de lesão (Baliki; Apkarian, 2015; Garland, 2012).

3. Genética

Algumas pessoas têm predisposição genética a sentir mais dor, a ter resposta mais intensa à dor, ou a apresentar menor tolerância a estímulos dolorosos ou mesmo inócuos (Baliki; Apkarian, 2015; Garland, 2012).

B.
Fatores Psicológicos

1. Expectativa

A expectativa de dor pode influenciar significativamente a experiência dolorosa. Por exemplo, se alguém espera que a dor seja intensa, de fato, ela pode ser, devido ao efeito psicológico da expectativa.

A relação entre dor e expectativa revela como processos emocionais e cognitivos podem influenciar a percepção da dor física. A dor, embora comumente vista como uma sensação puramente física, é profundamente modulada por fatores emocionais, culturais e psicológicos, sendo a expectativa um dos aspectos mais importantes dessa modulação.

A expectativa, em termos simples, é a crença ou previsão de que algo ocorrerá no futuro, seja isso bom ou ruim. No contexto da dor, ela pode ter um impacto significativo em como uma pessoa experimenta a intensidade, a duração e, até mesmo, a localização de uma dor. Estudos mostram que, quando as pessoas antecipam dor, devido à previsão de uma situação futura ou a uma condição clínica, elas relatam experiências de dor mais intensas do que se não tivessem tal expectativa.

Por exemplo, a expectativa de dor intensa em um procedimento clínico pode amplificar a sensação de dor nas situações em que a pessoa realmente a vivencia, configurando um fenômeno conhecido como "hiperalgesia induzida pela expectativa". Isso ocorre porque o cérebro, ao antecipar a dor, ativa áreas responsáveis por aumentar a vigilância e a atenção a sinais de desconforto, tornando-os mais intensos (Peters, 2015).

B.
Fatores Psicológicos

2. Ansiedade e depressão

Estados emocionais como a ansiedade e a depressão podem amplificar a percepção da dor, à medida que esta é interpretada como mais avassaladora quando a pessoa está em um estado emocional negativo. A relação entre ansiedade, depressão e dor é complexa e multifacetada, envolvendo uma interação entre fatores psicológicos, emocionais e fisiológicos.

Esses transtornos mentais não apenas afetam o estado emocional e comportamental de uma pessoa, mas também promovem impacto significativo na experiência da dor, podendo tanto agravar a percepção dolorosa quanto influenciar a forma como a dor é gerenciada. Compreender essa conexão é crucial para oferecer um tratamento mais eficaz e holístico aos indivíduos que sofrem dessas condições (Campbell; Edwards, 2009).

A ansiedade e a dor

A ansiedade é caracterizada por um estado de preocupação excessiva e de tensão emocional, muitas vezes acompanhada por sintomas físicos, como o aumento da frequência cardíaca, a sudorese e a respiração acelerada. A relação entre ansiedade e dor é observada de diversas maneiras, especialmente porque a ansiedade tende a aumentar a sensibilidade à dor. Isso ocorre devido à ativação das áreas cerebrais envolvidas tanto na percepção da dor quanto no processamento das emoções, como o córtex cingulado anterior e a amídala.

Quando uma pessoa está ansiosa, o corpo entra em um estado constante de alerta, o que pode resultar em uma amplificação da percepção de sensações dolorosas. Isso é conhecido como hiperalgesia, em que estímulos que normalmente seriam toleráveis se tornam intensos e insuportáveis. Além disso, a ansiedade pode gerar tensões musculares, o que contribui para dores físicas, como dores nas costas ou cefaleias tensionais.

Em indivíduos com ansiedade crônica, essa sensibilidade aumentada à dor pode se tornar um círculo vicioso. A dor causa sofrimento físico e emocional, o que, por sua vez, aumenta os níveis de ansiedade, perpetuando a experiência dolorosa e dificultando o controle da dor (Campbell; Edwards, 2009).

B.
Fatores Psicológicos

A depressão e a dor

A depressão, por sua vez, está fortemente associada a uma percepção alterada da dor. Estudos mostram que pessoas com depressão frequentemente relatam dores crônicas, como dores nas articulações, nas costas ou cefaleias. A relação entre depressão e dor é mediada por uma série de fatores, incluindo alterações na química cerebral e no processamento emocional da dor.

Em indivíduos deprimidos, há redução da atividade de neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina, que são essenciais tanto para a regulação do humor quanto para a modulação da dor. A diminuição desses neurotransmissores pode tornar a pessoa mais sensível à dor, além de reduzir sua capacidade de lidar com ela. Além disso, a depressão frequentemente leva à diminuição de atividade física e ao isolamento social, o que pode agravar a dor, uma vez que o movimento e o apoio social desempenham um papel importante na gestão da dor.

A experiência de dor crônica em pessoas com depressão também está relacionada ao aumento do sofrimento emocional, pois a dor persistente possivelmente intensifica sentimentos de desesperança e impotência, características centrais da depressão. Isso cria uma espiral negativa, em que a dor e a depressão se reforçam mutuamente, tornando mais difícil para o indivíduo sair desse círculo (Campbell; Edwards, 2009).

A interseção entre ansiedade, depressão e dor

A ansiedade e a depressão frequentemente coexistem, e essa combinação pode amplificar ainda mais a dor. Quando ambos os transtornos estão presentes, o impacto sobre a percepção da dor é maior, o que torna o tratamento desafiador. A interação entre esses fatores pode ser explicada por diversos mecanismos biológicos e psicológicos.

Em nível cerebral, as áreas envolvidas na modulação da dor, como o sistema límbico e o córtex pré-frontal, também desempenham papel importante na regulação das emoções. Alterações nessas áreas, comuns tanto na ansiedade quanto na depressão, podem resultar em uma resposta mais intensa e persistente à dor. Além disso, a presença de distúrbios emocionais pode alterar a forma como a dor é processada, tornando-a mais difícil de controlar, e aumentar a percepção da sua intensidade (Campbell; Edwards, 2009).

B.
Fatores Psicológicos

3. Autoeficácia

A maneira como uma pessoa lida com a dor pode influenciar sua percepção. Estratégias de enfrentamento positivas, como distração ou relaxamento, ajudam a reduzir a dor, enquanto estratégias negativas, como catastrofização, podem piorá-la.

A relação entre **autoeficácia e dor** está profundamente enraizada na forma como as pessoas percebem e lidam com suas experiências dolorosas. O conceito de autoeficácia foi introduzido por Albert Bandura, psicólogo que destacou a importância da crença do indivíduo em sua capacidade de realizar tarefas e atingir objetivos. No contexto da dor, a autoeficácia refere-se à crença ou à confiança de uma pessoa em sua habilidade de gerenciar ou controlar a dor, para enfrentar desafios e resolver problemas, o que pode influenciar diretamente sua experiência dolorosa, sua resposta emocional e sua capacidade de lidar com a dor.

Todavia, a autoeficácia não é uma habilidade específica, mas uma crença geral sobre a capacidade de atingir objetivos e superar obstáculos. Em relação à dor, isso pode ser entendido como a atitude confiante e o controle de uma pessoa sobre sua dor, seja para aliviá-la, suportá-la, ou mesmo para prevenir sua intensificação (Edwards *et al.*, 2016).

B.
Fatores Psicológicos

A influência da autoeficácia na experiência da dor

Pesquisas indicam que a percepção de autoeficácia pode ter impacto significativo na intensidade da dor que uma pessoa sente e como ela a experimenta. Quando um indivíduo acredita que pode controlar ou gerenciar a dor, tende a relatar uma experiência menos intensa e a ter melhores resultados em termos de enfrentamento da dor. Isso ocorre por diversos motivos:

- **Redução da ansiedade e do medo:** a crença na autoeficácia pode diminuir a ansiedade associada à dor. Quando alguém acredita que tem as ferramentas ou os recursos para lidar com a dor, o medo desta tende a ser menor. Isso se traduz em uma redução na percepção da dor, já que o medo e a ansiedade podem amplificar a experiência dolorosa;
- **Aumento do controle sobre a dor:** quando as pessoas acreditam que têm controle sobre a dor, seja por meio de técnicas de enfrentamento, como exercícios e meditação, seja a partir de tratamento, elas tendem a tomar atitudes que podem, de fato, reduzir a intensidade da dor. A percepção de controle ajuda a fortalecer a capacidade de enfrentar a dor e pode diminuir o impacto emocional associado;
- **Engajamento em comportamentos saudáveis:** a autoeficácia é frequentemente associada a comportamentos de enfrentamento ativos e positivos. Indivíduos com alta autoeficácia tendem a estar mais dispostos e a participar de terapias físicas, seguir planos de tratamento, praticar exercícios regularmente e adotar estratégias de relaxamento, que são fundamentais para a gestão eficaz da dor.

Autoeficácia e dor crônica

Em casos de dor crônica, a relação entre autoeficácia e dor torna-se ainda mais relevante. A dor crônica é caracterizada por sua persistência e resistência ao tratamento convencional, o que pode levar a uma sensação de impotência. Nesse contexto, indivíduos com baixa autoeficácia tendem a se sentir mais derrotados pela dor, resultando no aumento da dor percebida e na piora do quadro geral.

Por outro lado, aqueles com alta autoeficácia em relação à dor crônica geralmente mostram melhores resultados. Eles tendem a adotar estratégias de enfrentamento mais eficazes, como a mobilização, práticas de relaxamento e ajustes comportamentais. Além disso, a crença de que possuem gestão da própria dor ajuda a combater os aspectos emocionais e psicológicos negativos associados à dor crônica, como a depressão e a ansiedade, que frequentemente agravam a dor (Edwards *et al.*, 2016).

B.
Fatores Psicológicos

4. Catastrofização

A catastrofização é uma resposta cognitiva distorcida, em que o indivíduo antecipa uma situação de forma extrema e negativa, imaginando consequências desastrosas. Nesse sentido, a catastrofização é um processo cognitivo em que o sujeito tende a interpretar eventos e experiências de forma exagerada e negativa, frequentemente antecipando o pior cenário possível, assim amplificando o sofrimento emocional.

A catastrofização tem relação profunda e complexa com a forma como a dor é percebida e experienciada. Nesse sentido, pessoas que catastrofizam frequentemente percebem a dor como mais intensa, incapacitante e insuportável do que realmente é, o que pode agravar o sofrimento físico e emocional.

No contexto da dor, isso pode significar a interpretação de uma dor leve ou moderada como insuportável, intensa e que levará a uma perda total de função ou a danos irreversíveis. Desse modo, a catastrofização não se limita a uma avaliação exagerada da dor, mas igualmente envolve ruminação constante sobre a dor e a preocupação excessiva com esta, o que pode agravar a experiência dolorosa (Campbell; Edwards, 2009).

A relação entre catastrofização e percepção da dor

A catastrofização tem um impacto significativo sobre como a dor é percebida e experienciada por meio de diversos mecanismos.

Amplificação da dor

A catastrofização tende a amplificar a percepção da dor, fazendo com que o indivíduo experimente uma dor mais intensa do que a que realmente está presente. Isso ocorre porque a antecipação de dor intensa e a preocupação excessiva em relação a esta ativam áreas do cérebro envolvidas no processamento de emoções, como a amídala e o córtex cingulado anterior, que estão diretamente relacionadas à percepção da dor. Esse processo aumenta a sensibilidade à dor, criando um círculo vicioso de sofrimento emocional e físico.

Ruminação e foco na dor

A catastrofização leva ao aumento da ruminação, ou seja, a tendência de se concentrar de forma obsessiva na dor. Isso pode levar à atenção exacerbada para os sinais de dor, tornando-os mais difíceis de ignorar e gerenciar. Quando uma pessoa foca incessantemente na dor, ela torna-a mais intensa e difícil de suportar, já que o foco constante nos sintomas dolorosos aumenta o sofrimento emocional associado a estes.

Aumento da ansiedade

A catastrofização é frequentemente acompanhada de ansiedade, que amplifica a percepção de dor. O medo de que a dor se agrave ou de que seja algo grave pode aumentar os níveis de estresse, o que, por sua vez, pode piorar a experiência dolorosa. A ansiedade também pode aumentar a tensão muscular e a hipervigilância, o que contribui para o aumento da dor percebida.

Diminuição da autoeficácia

Pessoas que catastrofizam tendem a ter crença reduzida na capacidade de lidar com a dor, o que diminui a autoeficácia. Quando alguém acredita que não consegue controlar ou aliviar a sua dor, a sensação de impotência pode aumentar o sofrimento. Essa falta de confiança nas próprias habilidades de enfrentamento possivelmente levará a uma maior vulnerabilidade emocional, o que intensifica a dor.

Impacto no funcionamento diário

A catastrofização pode fomentar a percepção exagerada das limitações impostas pela dor, resultando em comportamentos de evitação, como a restrição excessiva de atividades cotidianas. Dessa forma, aumenta-se a sensação de incapacidade e a perda de qualidade de vida. Ao evitar atividades, a pessoa pode enfraquecer seus músculos e perder a mobilidade, o que pode, paradoxalmente, aumentar a dor e a incapacidade a longo prazo.

A catastrofização e a dor crônica

A catastrofização é especialmente problemática em casos de dor crônica, uma vez que pessoas com essas condições, como a fibromialgia, a artrite reumatoide ou a dor lombar crônica, frequentemente catastrofizam devido à natureza persistente e imprevisível da dor. Esse tipo de pensamento pode transformar um episódio de dor em uma experiência emocionalmente insuportável, criando um círculo vicioso em que a catastrofização aumenta a dor, e a dor, por sua vez, intensifica os pensamentos catastróficos. Desse modo, esse fenômeno pode resultar em sofrimento contínuo e no pior prognóstico ao paciente, pois a catastrofização geralmente diminui a adesão ao tratamento e às estratégias de enfrentamento (Campbell; Edwards, 2009).

B.
Fatores Psicológicos

5. Medo e cinesiofobia

A relação entre medo, cinesiofobia (medo do movimento) e dor está frequentemente associada à forma como o corpo e a mente reagem a lesões ou condições crônicas (Afridi *et al.,* 2021; Bushnell; Ceko; Low, 2013; Gilam *et al.,* 2020; O´Gara *et al.*, 2021; Phelps; Navratilova; Porreca, 2021).

Medo

O medo é uma resposta emocional natural a uma ameaça percebida. No contexto da dor física, o medo pode surgir quando dado indivíduo tem receio de que o movimento ou a atividade física possa agravar a dor ou causar mais lesões. Esse medo pode ser um fator psicológico relevante em doenças crônicas, como a dor lombar crônica ou a fibromialgia, em que a pessoa pode temer se mover e, com isso, fomentar o desconforto.

Cinesiofobia

A cinesiofobia é o medo irracional de se mover ou de realizar atividades físicas, geralmente causado pela dor ou por uma experiência traumática com o movimento. Quando alguém sofre de dor aguda ou crônica, pode começar a evitar certos movimentos ou atividades em função do receio de que a dor piore, o que pode levar a um ciclo de inatividade e fraqueza muscular. Isso tende a perpetuar a dor, dificultando, portanto, o processo de recuperação.

Dor

A dor, especialmente quando crônica, pode gerar uma resposta emocional negativa, como o medo de que o movimento ou o esforço físico leve à exacerbação da dor. Com o tempo, isso reforça o desenvolvimento da cinesiofobia, em que a pessoa evita se mover, o que pode enfraquecer os músculos, reduzir a flexibilidade e aumentar a percepção da dor, criando um círculo vicioso.

Em resumo, o medo de sentir dor pode gerar cinesiofobia, que leva à imobilidade, que, por sua vez, pode piorar a dor devido à falta de movimento. Portanto, é fundamental tratar essa interação de forma holística, abordando tanto os aspectos físicos quanto os emocionais e comportamentais da dor, a fim de interromper esse ciclo e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso pode incluir terapia física, treinamento de movimento, apoio psicológico e, em alguns casos, tratamentos farmacológicos ou terapias cognitivas.

C.
Fatores Ambientais e Sociais

1. Cultura e Aprendizado Social

A maneira como a dor é entendida e tratada pode variar de cultura para cultura. Em algumas, a dor é vista como um sinal de resistência e força; em outras, pode ser um sinal de fragilidade. O aprendizado social, ou seja, as experiências e expectativas das pessoas ao redor, também influencia a forma como interpretamos a dor.

2. Suporte Social

O apoio de amigos, familiares e profissionais de saúde pode reduzir a percepção de dor, fornecendo conforto emocional e prático. A dor tende a ser mais suportável quando a pessoa sente que é compreendida e apoiada.

3. Ambiente

O ambiente em que uma pessoa se encontra pode afetar sua percepção da dor. Ambientes calmos, seguros e confortáveis tendem a diminuir a dor, enquanto ambientes estressantes, intensificá-la.

Considerações finais

A dor é um processo altamente complexo, que vai além da simples resposta a um estímulo nocivo. A percepção da dor é influenciada por uma rede interconectada de fatores fisiológicos, psicológicos, ambientais e sociais. Dessa forma, compreender tais interações é essencial para o desenvolvimento de tratamentos eficazes para a dor, especialmente em condições crônicas. O modelo biopsicossocial da dor a reconhece não apenas como um fenômeno físico, mas também como uma experiência subjetiva, a qual envolve o corpo, a mente e o ambiente social.

Referências

AFRIDI, B.; KHAN, H.; AKKOL, E. K.; ASCHNER, M. Pain perception and management: where do we stand? **Current Molecular Pharmacology,** [S.l.], v. 14, n. 5, p. 678–688, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.2174/1874467213666200611142438.

ARCHIBALD, J.; WARNER, F. M.; ORTIZ, O.; TODD, M.; JUTZELER, C. R. Recent advances in objectifying pain using neuroimaging techniques. **Journal of Neurophysiology**, v. 120, n. 2, p. 387-390, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1152/jn.00171.2018.

ASHMAWI, H. A. **Tratos ascendentes. Vias facilitatórias. Sistemas endógenos de controle da dor.** Aula ministrada no Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia e Terapêutica da Dor, São Paulo, 18 maio 2016. Apresentação em aula.

BALIKI, M. N.; APKARIAN, A. V. Nociception, pain, negative moods, and behavior selection. **Neuron,** [S.l.], v. 87, n. 3, p. 474–491, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.06.005.

BUSHNELL, M. C.; CEKO, M.; LOW, L. A. Cognitive and emotional control of pain and its disruption in chronic pain. **Nature Reviews. Neuroscience,** v. 14, n. 7, p. 502-511, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1038/nrn3516.

CAMPBELL, C. M.; EDWARDS, R. R. Mind-body interactions in pain: the neurophysiology of anxious and catastrophic pain-related thoughts. **Translational Research: The Journal of Laboratory and Clinical Medicine,** v. 153, n. 3, p. 97-101, 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.trsl.2008.12.002.

EDWARDS, R. R. *et al.* The role of psychosocial processes in the development and maintenance of chronic pain. **The Journal of Pain,** v. 17, n. 9, supl., p. T70-T92, set. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jpain.2016.01.001.

EUROPEAN PAIN FEDERATION (EFIC). **Biopsychosocial Model of Pain.** Brussels, 2024. Infográfico. Disponível em: https://europeanpainfederation.eu/wp-content/uploads/2024/12/SIP-INFOGRAPHIC-03-Print.pdf. Acesso em: 22 jul. 2026.

GARLAND, E. L. Pain processing in the human nervous system: a selective review of nociceptive and biobehavioral pathways. **Primary Care,** v. 39, n. 3, p. 561-571, set. 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.pop.2012.06.013.

GILAM, G. *et al.* What is the relationship between pain and emotion? Bridging constructs and communities. **Neuron,** v. 107, n. 1, p. 17-21, 1 jul. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.05.024.

O'GARA, B. P. *et al.* Sleep, pain, and cognition: modifiable targets for optimal perioperative brain health. **Anesthesiology,** v. 135, n. 6, p. 1132-1152, dez. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000004046.

PETERS, M. L. Emotional and cognitive influences on pain experience. **Modern Trends in Pharmacopsychiatry,** [S.l.], v. 30, p. 138–152, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1159/000435938.

PHELPS, C. E.; NAVRATILOVA, E.; PORRECA, F. Cognition in the chronic pain experience: preclinical insights. **Trends in Cognitive Sciences,** v. 25, n. 5, p. 365-376, maio 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.01.001.

TRACEY, I. Imaging pain. **British Journal of Anaesthesia,** v. 101, n. 1, p. 32-39, jul. 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1093/bja/aen102.

MANEJO DA
DOR CRÔNICA
NA APS

Ficha técnica

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS
Departamento de Promoção da Saúde - DEPROS
Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - COPICS

Coordenação Geral:
Paulo Roberto Sousa Rocha
COPICS/DEPROS/SAPS/MS
Daniel Miele Amado
COPICS/DEPROS/SAPS/MS

Equipe Técnica:
Nathalia Oliveira da Silva
COPICS/DEPROS/SAPS/MS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Reitoria
Ursula Rosa da Silva

Vice-Reitoria
Eraldo dos Santos Pinheiro

Coordenação Geral
Julieta Carriconde Fripp
Coordenadora da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL.

Coordenadora Adjunta
Simone da Fonseca Sanghi
Assistente Social da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Colaboradora dos processos de Gestão na Cuidativa.

CUIDATIVA CENTRO REGIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS • UFPEL
UFPEL
PNPIC Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS
SUS 35 ANOS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO DO BRASIL DO LADO DO POVO BRASILEIRO

MANEJO DA
DOR CRÔNICA
NA APS

Ficha técnica

CRÉDITOS DO CURSO

Coordenação Geral
Paulo Roberto Sousa Rocha
Julieta Carriconde Fripp
Simone da Fonseca Sanghi

Apoio Administrativo / Secretaria
Luciano Avila dos Santos

Coordenação de Conteúdo
Amirah Adnan Salman
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Consultoria e Revisão de Conteúdos
Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Julieta Carriconde Fripp
Manuela Samir Maciel Salman
Nathalia Oliveira da Silva
Paulo Roberto Sousa Rocha
Simone da Fonseca Sanghi

Coordenação Pedagógica
Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Coordenação de Pesquisa e Relatórios
Luiz Augusto Facchini
Elaine Thumé
Elaine Tomasi

Coordenação de Mídias e Comunicação
Samir Salman
João Rocha Rodrigues
Luana Copini Jahn

Coordenação de Tecnologia e Informação
Alessander Osório

Coordenação da Produção
Alexandre Moretto Ribeiro
Andrea Cristina Lovato Ribeiro

Revisão Gramatical/Ortográfica e ABNT
Giulia M. Delazzeri

Coordenação de Atividades e Logística de Campo:
Paulo Roberto Sousa Rocha

Produção Audiovisual
Eduardo Dias Abreu

Assistente de Produção Audiovisual
Luciana Melo

Animação
Márlon Lima

Ilustração
Mario Cau
Barlo Moreira (cores)

Diagramação e Design Gráfico
Danielle Rossi

Design Web e Programação
Vando Pinto

CRÉDITOS DESTE RECURSO DIDÁTICO

Conteúdo
Josimari Melo de Santana

CUIDATIVA CENTRO REGIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS • UFPEL
UFPEL
PNPIC Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS
SUS 35 ANOS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO DO BRASIL DO LADO DO POVO BRASILEIRO